



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منى زكريا محمد احمد
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الجيزة
رقم البطاقة : 27710082103588 رقم التليفون : 01007616576
العمر (تاريخ الميلاد) : 08-10-1977 المهنة : ربه منزل
العنوان : امبابة
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الاورام

[11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى زكريا محمد احمد National ID: 27710082103588	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

منى
زكريا محمد احمد
٢٧ ش ابراهيم عبدالجبار
امبابة - الجيزة

١٩٧٧/١٠
٢٧٧ ١٠ ٠٨ ٢١ ٠٣٥ ٨٨
L16254495

٢٠٢٥/٠٨ ٢٧٧ ١٠ ٠٨ ٢١ ٠٣٥ ٨٨
حاصلة على دبلومة الإدارة ومكتاترية

أنش
ايمن محمد بخاريه حسنين الصيفي
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٨/٢١

متزوجة مسلمة

DMS



Patient's Name: mona za :d
Date: 2026-04-01
Referred by: Prof.Dr. ct cap
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE NON CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN
AND PELVIS REVEALED:**

Known case of CA breast

as compared to previous study dated 8/10/2025, the current study revealed.

I- CHEST:

- Porta cath is noted.
- Left breast skin thickening and heterogenous density for sono-mammography.
- Still seen small right upper and middle lobe pulmonary nodules measuring 3 mm and 5 mm respectively.
- No pulmonary masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few subcentimetric mesenteric lymph nodes.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal plain C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal plain CT appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Multiple subcentimetric mesenteric and bilateral external iliac lymph nodes.
- No ascites.

III- Examined skeleton

- Stationary course regarding
- the scattered vertebral sclerotic areas.
- D1 vertebral body collapse with D10, D11 and L5 vertebral wedging.

Opinion:

- ❖ Overall stationary course

Dr.sherif Wagdy

Name: مني زكريا محمد احمد			
MR. : 155			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient presented for Tykerb and Xeloda therapy, with Xeloda prescribed at a dose of 3 × 2 × 14 and Tykerb at 5 × 1 × 30.			
The patient continued on Xeloda 3 × 2 × 14 and Tykerb 5 × 1 × 30, with a pending new assessment.			
A CT of the chest, abdomen, and pelvis performed in April 2026 was reviewed, and the plan was to continue Tykerb plus Xeloda 3 × 2 × 14 with the next visit scheduled for early September 2026.			
Laboratory studies were obtained and accepted for continuation of Tykerb plus Xeloda, and the next follow-up appointment was scheduled for early October 2026.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		19-09-2026	
الوقت :			
الطبيب المعالج :		علياء احمد أبو النصر شهاب الدين	
يعتمد ,			

Patient Name: Mona Zakareya Mohamed Ahmed

Date : 08/10/2025

Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)

Age : 48 Year(s)

Medical ID: 5101/2022

Pat. ID: 25789

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,

As Compared to prior study dated 11/12/2024 ; the current study revealed:

I Chest:

- The left breast shows mild heterogenous parenchyma with overlying skin thickening for correlation with sonomammography .
- **Stationary course regarding size and number of**
 - Middle lobe pleural based 5 mm nodule/tag.
 - Tiny right upper lobe pulmonary nodule measured 3mm.
- **Otherwise** no newly developed nodules or pulmonary consolidations.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Right sided porta cath, its tip in right atrium.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of enlarged in size with homogenous CT texture with no definite hepatic focal lesion on noncontrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenal's.
- Mild diffuse mural thickening of the urinary is noted.
- IUCD seen in place.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.

III Bone scan show : Stationary course regarding

- Wide spread sclerotic osseous lesions with still noted collapse of D1 vertebral body.
- Central wedging of L5 & anterior wedging of D10 and D11.

Opinion:

- Findings suggestive of mild cystitis.
- Otherwise rather stationary course since the last study.

Signature Prof. Ali Remah
09/10/2025 05:00



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : منى زكريا محمد احمد

Sex:

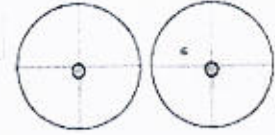
3- Medical number:
Female

83114102
Old Med :

Old Med
5101-2022

2-ID number: 2771002103588

Patient Age : 46 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01007616576

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
REASON

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2025-04-13

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal
status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CTS-->PROGRESSION REGARDING BONE LESION

BX

IDC

BX COMMENT

ER

0/8

ER COMMENT

PR

0/8

PR COMMENT

Her 2 Neu

3

Her 2 Neu COMMENT

SISH

SISH COMMENT

Ki67

50

T

N

M

1) bone

Sonomammography

PATIENT HISTORY

11/2022-->DENOVO METS LT BREST CA TO AXLNS AND BONE

RECEIVED PELVIC PALLIATIVE RTH TO LUMBOSACRAL

STARTED TAXOL|+ HERCEPTIN SO FAR 23 WK TAXOL

CONSULTING REGARDING STOPPING TAXOL AND CONTINUE ON HERCEPTIN DUE TO PN GII

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for bone scan

tykerb / xeloda

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

Patient Name: Mona Zakareya Mohamed Ahmed	Date : 26/11/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 2829	

**Combined bilateral breast mammography and complementary
ultrasound**

Indication:

left breast palpable lump.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UOQ focal asymmetry with pelomnorphic calcifications involving an area about 9 x 5.8 cm and 5.5 cm away from the nipple.
- No right suspicious masses.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular spiculated hypoechoic mass lesion, with vascularity detected within on color Doppler, seen at 2 to 3 o'clock position measuring 3.2 x 6 cm, consistent to the palpable lump.
- Another similar yet smaller is seen medially to the index lesion measures 11 x 13 mm with unhealthy intervening parenchyma and suspected ductal extension.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Multiple Pathological left axillary level I, II & III lymph nodes are seen with muffled hila, the largest one measuring 25 x 21 mm.
- Nonspecific right axillary LN.
- Free supra-clavicular regions.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking mass lesion (BIRADS 5) for histopathological correlation.
- Pathological left axillary LNs.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Dr. Wafaa Ali

Signature Temp

26/11/2022 2:48 PM

atient Name : الأستاذ / منى زكريا محمد	Request No. : 13002326
atient No. : 27710082103588	Request Date : 28/11/2022
ath No. : 3592/22	Verification Date : 25/12/2022
ex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
ge : 45 Y	Department : Out Patient
eferreing Doc. :	IHC No. :
	Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

anical data:
ft breast UOQ lesion

ture of specimen:
cut biopsy, collected at 28/11/2022 , 10:00 pm

oss examination
Multiple greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.
ctions prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER,
HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

roscopic examination:
istological type: Invasive duct carcinoma .
rade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
CIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
gioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
No nuclear reaction intumor cells (Allred score 0/8)
No nuclear reaction intumor cells (Allred score 0/8).
-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
67: 50 % nuclear reaction in tumor cells

gnosis:
t breast UOQ lesion, tru cut biopsy:
asive duct carcinoma, Grade II .
Negative (score 0/8).

Verified by :
dr.esraa magdy





Patient Name : الأستاذ / منى زكريا محمد	Request No. : 13002326
Patient No. : 27710082103588	Request Date : 28/11/2022
Path No. : 3592/22	Verification Date : 05/12/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 45 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:

Left breast UOQ lesion

Nature of specimen:

Tru cut biopsy, collected at 28/11/2022 , 10:00 pm

Gross examination

Multiple greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.

Microscopic examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma .
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
- * DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
- *Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved

Diagnosis:

Left breast UOQ lesion, tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II .

For further IHC (ER,PR,HER2,Ki67) ←

Prof.Gamal Abdelatty

Dr.Heba Hassan

Verified by :

dr.esraa magdy

Name:	MONA ZAKRYA MOHAMED	Date:	25/03/2025
Referred by:	م / مستشفى اورام دار السلام	Age:	48 years

CT SCAN OF THE ABDOMEN & PELVIS**Findings:****Limited non-contrast study**

- The liver is of average size with homogenous CT texture and regular outlines. No focal lesions could be detected on non-contrast basis.
- No hyper-dense gall stones could be seen
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions could be seen on non-contrast basis.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra renal glands.
- No pelvi-abdominal ascites, masses or pathologically enlarged lymph nodes.
- Partially filled urinary bladder is seen with no gross mural thickening, masses, stones or diverticulae.
- Average-sized uterus with contraceptive device within.
- Unremarkable rest of pelvic structures.
- Right iliac bone sclerotic lesion for clinical correlation .

Badr Hasan
Dr. Sheriff Abdel-Fatah, M.D.

Hala

فرع ورقاق

لا شارع كورنيش النيل - أمام
فرع التوحيد والنور - ورقاق الجسر
الوراق

فرع عزبة الصعيدية

شارع عبد المنعم مهران - عزبة
الصعيدية - أمام مستشفى أولاد
عمرو - أمام

فرع أمبابة

شارع نادي أمبابة الرياضي - بحوار
مسجد الجمعة السريعة - أمام
بنك مصر



Name:	MONA ZAKRYA MOHAMED	Date:	25/03/2025
Referred by:	م / مستشفى اورام دار السلام	Age:	48 years

NON-CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST

Findings:

- Deep place right-sided central venous line.
- Middle lung lobe small pulmonary nodule for follow up .
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.
- *Edematous skin thickening of the left breast is seen, for sono-mammography.*

OPINION:

- ***Middle lung lobe small pulmonary nodule for follow up.***

Badr Hasan
 Dr. Sheriff Abdel-Fatah, M.D.

Hala

فرع الوراق :

٢٧ شارع كورنيش النيل - امام
 فرع التوحيد والنور - وراق الحضر
 الوراق

فرع عزبة الصعايدة :

شارع عبد المنعم عسران - عزبة
 الصعايدة - اعلى مسجد اولاد
 عمرو - امبابه

فرع امبابه :

شارع نادي امبابه الرياضي - بحوار
 مسجد الجمعية الشرعية - امام
 بنك مصر